جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * **طلب علاج أول مرة / متردد**

إسم المريض رباعياً : فايزه محمد احمد غنيمي
المحافظة : القليوبيه **الحي / المدينة :** شبرا الخيمه ثان **العنوان :** 0
رقم البطاقة : 25210091401109 **رقم التليفون :** 01220088231 **تاريخ تسجيل الإستمارة :** 24-10-2026
العمر(تاريخ الميلاد) : 09-10-1952 **المهنة :** ربه منزل

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:-التأمين الصحي-القوات المسلحه-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

المقر بما فيه
التوقيع:(----------)

الإخصائي الاجتماعي
التوقيع:(----------)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان القولون
نتائج الأبحاث : (مرفق)
التشخيص النهائي : سرطان القولون
خطة العلاج : أبحاث أورام اشعه مقطعيه علي البطن والصدر والحوض بالصبغه [11127]
قسم العلاج : الاورام
التعليق على التشخيص : ----------

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/ندى حسن **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/نرمين رمضان **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية.
كما تقر اللجنة بأن البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.

تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة و مدير المستشفي.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفي قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

ا.د/ ---------- **ا.د/** ---------- **د/** ---------- **د/** ----------

قرار اللجنة

التشخيص النهائي : ----------
خطة العلاج : ----------
المستشفي : ----------**قسم :** ----------
جهة العلاج : ----------**نفقات :** ----------
ملاحظات : ----------

رئيس	مدير عام	ختم
المجلس الطبي المتخصص	مديرية الشئون الصحية	شعار الجمهورية

Name: فايزه محمد احمد غنيمي
National ID: 25210091401109

تقرير طبي

السيد

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

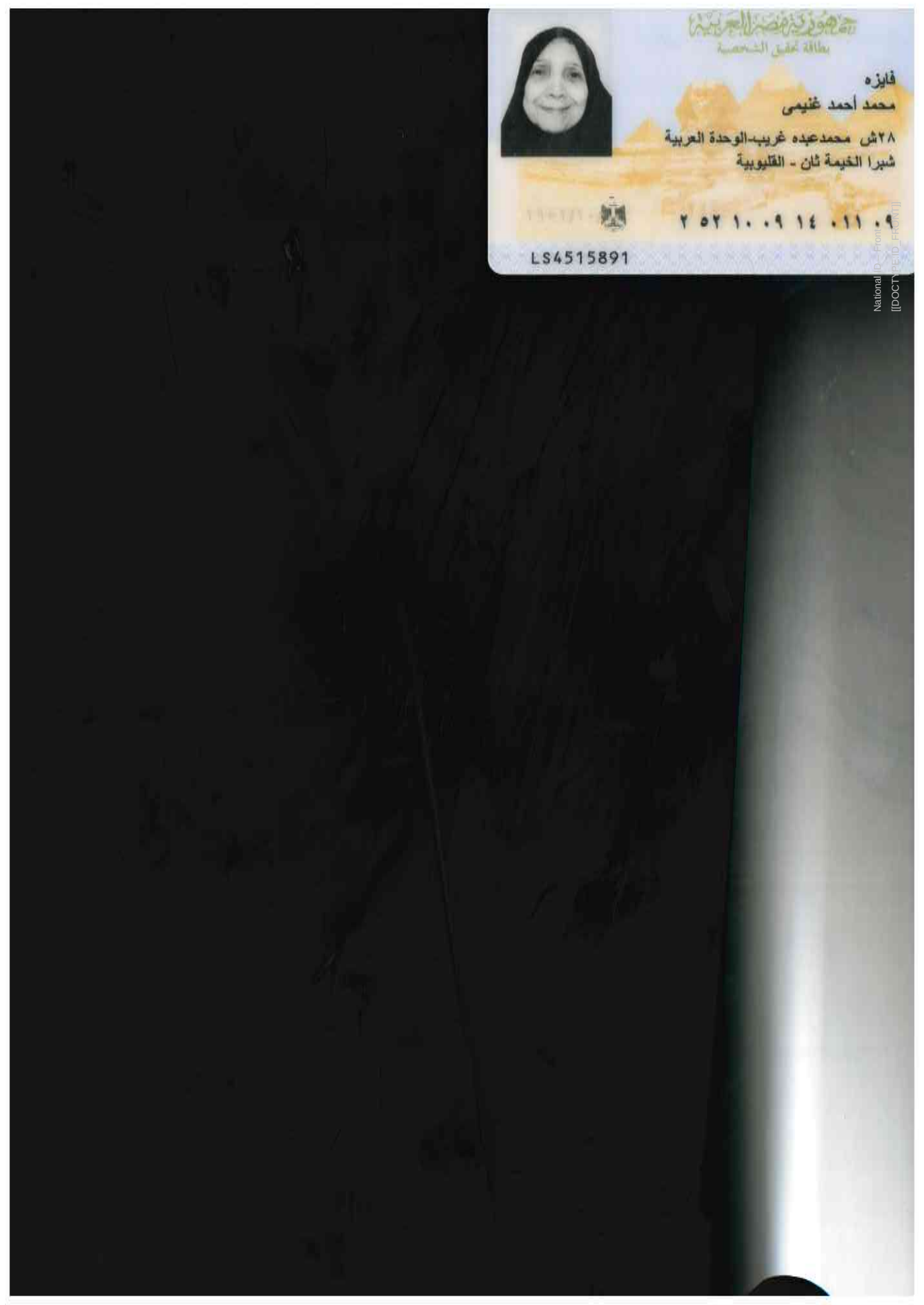
نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انة

A patient of colon cancer for Contrast-enhanced CT Chest & abdomen and pelvis

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين


جمهورية مصر العربية
بطاقة تحقيق الشخصية
فايزه
محمد أحمد غنيمى
٢٨ش محمدعبده غريب-الوحدة العربية
شبرا الخيمة ثان - القليوبية
٢٥٢١٠٠٩١٤٠١١٠٩
LS4515891
National ID - Front
[[DOCTYPE:ID_FRONT]]


٢٥٢١٠٠٩١٤٠١١٠٩ ٢٠٢٦/٠٤
ربة منزل
أنثى مسلمة أرملة
١١ البطاقة سارية حتى ٢٠٣٣/٠٤/٢٦
National ID - Back
[[DOCTYPE:ID_BACK]]

specialized Radiology Center
المركز التخصصى للأشعة

د.سامح صابر
أستاذ الأشعة بكلية الطب - جامعة الزقازيق

Patient Name : فايزه محمد
Refering Doctor :
Date : 6 August 2026

TRIPHASIC HELICAL CT EXAMINATION OF THE ABDOMEN & PELVIS REVEALS;

-**LIVER** *is average in size with cirrhotic density*. Its contour is irregular. No biliary radicles dilatation

Arterial phase:

- *A well-defined solid mass about 55x56 mm is seen at RT lobe (segment 8). The mass shows faint heterogeneous enhancement.*
- No other enhancing focal mass.

Venous phase:

- The liver parenchyma shows diffusely homogenous enhancement *with wash out of enhanced RT lobe mass.*
- Enhanced portal vein, no signs of thrombosis.

Delayed phase:

- *Complete wash out of the RT lobe mass.* No delayed enhancing masses.

-Multiple enlarged pelvi-abdominal L.Ns seen at pre-, para-aortic, aorto-caval, retro-caval, bilateral common, RT external iliac & RT inguinal regions, the largest measures about 65x60 mm seen at RT iliac fossa region.
-Cuts through **GALL BLADDER** revealed **few dense stones.**
-**SPLEEN** is average in size . No masses.
-**KIDNEYS** show normal sized with preserved renal parenchyma. No stones or hydronephrosis. Good excretory function. No masses.
-Normal contrast filled stomach, intestine & colon. No masses.
-Normal CT appearance of pancreas and adrenal glands.
-**Urinary bladder** is normally distended with no stones or masses.
-No para-aortic, portahepatis and iliac lymphadenopathy.
-No free ascites.
-Free both lung bases.

IMPRESSION:

- **RT hepatic focal lesion cope with hepatoma on top of cirrhotic liver.**
- **Calcular GB.**
- **Metastatic pelvi-abdominal lymphadenopathy.**

Best Regards;
Dr./ Sameh Saber; MD

Dr. Sameh Saber

منيا القمح : ٤٨ ش سعد زغلول - بجوار موقف أتوبيس شرق الدلتا - أمام معمل البرج
ت : ٠٥٥/٣٦٦٧٨١٠ - ٠١٠٤١٦٩٦٠٤
الزقازيق : شارع الغشام - مول نيو لايف - الدور الأولى علوى - عيادة رقم ٢٠
ت : ٠١٠٤٤٧٩٥٣٠٦ - ٠١١١٣٩٣٩٨٣٠ - ٠١٥٥١٠٤٨٥١٠

[[DOCTYPE:CT_SCAN]]
CT Scan

MULTI-SLICE CT SCAN OF THE ABDOEMN AND PELVIS:

Findings:

-A short segment of irregular circumferential **mural thickening and mass** is seen involving the caecum proximal ascending colon measuring 5x5cm at maximum length.it shows **heterogeneous pattern of enhancement** .

-

-

-Associated pericolic regional and mesenteric,para aortic and retrocaval pathological enlarged lymph nodes, the largest is seen measuring about 4,5x4,5cm at maximum diameter with hetergenous densities and faint enhancement .

-The liver is of average size with homogenous CT texture with no contour irrgularties. Right lobe focal lesions measuring 4x3,8cm with heterogeneous avid enhancement at the arterial phase and wash out at the delayed phase.
-Patent homogenously enhancing portal vein and its main branches as well as its main tributaries.
-No intra-hepatic or extra-hepatic biliary radicles dilatation.
-Normal appearance of the spleen, pancreas, both kidneys and suprarenal glands.apart from simple left kidney cyst
-Normal appearance of the pelvic organs.
-No abdominal or pelvic masses or collections.
- scanned lung bases thickened pleural bases with foci of calcification

Opinion:

- cecal and Proximal ascending colon heterogeneous soft tissue mass showing features suggestive of neoplastic process (colonic carcinoma) for histopathological correlating.
-Associated with:

Regional and para aortic (plevi abdominal) enlarged pathological lymph nodes likely metastatic
Right hepatic focal lesion likely metastatic